鈣片怎麼選？院內與市售鈣片比較

給副甲狀腺低下、甲狀腺手術後低血鈣，需要長期吃鈣片與活性維生素 D 的病人

> 鈣片要比的是**「元素鈣」**，不是藥名上的毫克數。例如 A-Cal 500 mg 是「碳酸鈣 500 mg」，真正的鈣只有 **200 mg**。我們開給您的目標通常是**每天元素鈣多少 mg**，換鈣片時請用下表換算顆數。

院內鈣片與活性維生素 D（高醫附院、岡山，2026-10-22 查詢）

品名	鈣的種類	元素鈣	維生素 D	吃法與注意
A-Cal 佳立鈣 500 mg 錠	碳酸鈣	**200 mg / 錠**	無	隨餐吃（需要胃酸才吸收好）；最常用
Biocal Plus 滋骨加強咀嚼錠	磷酸三鈣	**450 mg / 錠**	D3 330 IU	咀嚼後吞；含磷，血磷偏高者不適合
鈣立德發泡錠（附院限定，需簽呈）	碳酸鈣＋葡萄糖乳酸鈣	**1000 mg / 錠**	D3 880 IU	溶於一杯水喝；含鈉（碳酸氫鈉），一錠量大，最好分次
葡萄糖鈣丁片（供應不穩定）	磷酸氫鈣＋葡萄糖酸鈣	**104 mg / 錠**	D2 330 IU	含量低，要吃很多顆；含磷
Boca 立樂鈣乳劑 180 mL	磷酸三鈣	**約 38.5 mg / mL（推算）**	D3 160 IU / mL	含磷；含維生素 A 1600 IU / mL，長期大量要注意；仿單只標示鈣鹽量
U-Ca 活維D 0.25 mcg 膠囊	不含鈣；是**活性維生素 D3（calcitriol）**，幫助腸道吸收鈣		calcitriol 0.25 mcg	副甲狀腺低下的主要用藥之一；**不能用市售維生素 D 取代**

院內目前沒有檸檬酸鈣、alfacalcidol、單方維生素 D3。

市售常見鈣片（好市多等，依台灣包裝營養標示，2026-10-22 查詢）

品名	鈣的種類	元素鈣	維生素 D	其他 / 包裝建議量
科克蘭 鈣加維生素 D3 二合一錠（好市多）	碳酸鈣	**600 mg / 錠**	275 IU / 錠	每日 2 錠；隨餐
科克蘭 檸檬酸鈣鎂鋅錠（好市多）	檸檬酸鈣	**250 mg / 錠**	125 IU / 錠	含鎂、鋅；包裝建議每日最多 2 錠（＝500 mg）
挺立 高鈣強力錠＋K2	碳酸鈣	**600 mg / 錠**	250 IU / 錠	含鎂、鋅、K2；隨餐
挺立 鈣迷你錠	碳酸鈣	**300 mg / 錠**	250 IU / 錠	小顆好吞；每日 2 錠；隨餐
威德 檸檬酸鈣粉包	檸檬酸鈣	**315 mg / 包**	200 IU / 包	粉包；每日 1–3 包，飯前飯後都可

市售品一律以您手上包裝的營養標示為準（配方可能改版）。市售品的維生素 D 是一般維生素 D3，不是活性 D，不能取代 U-Ca。

碳酸鈣 vs 檸檬酸鈣

	碳酸鈣	檸檬酸鈣
含鈣比例	約 40%（顆數少）	約 21%（顆數多）
怎麼吃	**一定要隨餐**	空腹或隨餐都可
適合	多數人；同時可降血磷	吃胃藥（PPI）、胃切除後、碳酸鈣便秘脹氣者
常見副作用	便秘、脹氣、打嗝	較少便秘

怎麼吃最有效？

- **分次吃**：每次元素鈣 500 mg 以內吸收最好，一天分 2–3 餐。
- **和甲狀腺素至少間隔 4 小時**；鐵劑、部分抗生素（quinolone、tetracycline 類）也要錯開時間，間隔多久請問藥師。
- **U-Ca 照醫師開的次數吃**，不要自行加量；它的作用強，過量會高血鈣。
- 多喝水，少吃鹹（鈉高會讓尿鈣變多）；不要自行併用其他含鈣保健品，要先告訴醫師算進總量。

什麼時候要盡快回診或掛急診？

可能太低（低血鈣）：嘴巴周圍或手腳發麻、刺痛，手腳抽筋或手指僵硬內縮，**喉嚨緊、呼吸困難、抽搐**（急診）。

可能太高（高血鈣）：很口渴、尿很多、噁心嘔吐、便秘加重、倦怠、意識不清。出現時先停 U-Ca，盡快回診驗血。

> 調整鈣片或 U-Ca 劑量後，通常 **1 週左右要抽血**看血鈣；穩定後也要定期檢查血鈣、磷、腎功能與 24 小時尿鈣，避免長期尿鈣過高傷腎或造成腎結石。

高醫內分泌新陳代謝內科 盧子文醫師｜依據：Khan AA, et al. J Bone Miner Res 2022;37:2568（第二屆國際副甲狀腺低下工作坊指引）；Bollerslev J, et al. Eur J Endocrinol 2015;173:G1（ESE 指引）；院內藥品資料與仿單；好市多台灣商品營養標示。本單為一般衛教，實際劑量請依醫師處方。
工具版本：2026-10-22